



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CLÍNICA/SANATORIO

El sistema objeto de nuestro análisis es el de una Clínica privada en el interior provincial; con un alto volumen de atención a las necesidades de salud de pobladores de las localidades de su radio de influencia y una permanente interacción con todas las Obras Sociales que ofrecen cobertura en la región.

Ofrece los siguientes servicios: Internación Clínica (no infecto-contagiosas) y Quirúrgica (incluyendo traumatología quirúrgica), Servicio de Terapia Intensiva Adultos y otro Infantil / Neonatal, Servicio de Ginecología y Obstetricia, Nursery, Servicio de Guardia (para la atención de emergencias/urgencias que surjan y revisión de internados en piso), Consultorios Externos de atención ambulatoria en las distintas especialidades y una Administración centralizada de internados. Los Centros Prestacionales conexos son: Diagnóstico por Imágenes (Radiología, Ecografías y TAC=Tomografías Axiales Computadas); Laboratorio de Análisis Clínicos (Bioquímica, Bacteriología y RIE=Radio Inmuno Ensayo); Hematología (Análisis clínicos hematológicos y un Banco de Sangre); Hemodinámica; Diálisis (para pacientes crónicos ambulatorios, como internados emergentes); Botiquín (provisión de medicamentos a internados).

A nivel organizativo, la Clínica dispone de las siguientes áreas funcionales:

- **Servicios Especializados:** todos los servicios especializados que se brindan a internados (como aquellos que también se pueden prestar a pacientes ambulatorios), poseen su “propia administración” y dirección médica específica que interactúa con Administración Central para la atención de internados.
- **Administración Central:** encargada de centralizar las normativas médicas operativas de internados, la administración del personal en relación de dependencia con la Clínica, la locación de servicios a profesionales individuales, la coordinación administrativa y de establecer las pautas de relación con Obras Sociales y Profesionales que prestan servicio en la Clínica.
- **Mesa de Entrada:** para la admisión de internados, la centralización (entrega y recepción) de toda autorización de estudios complementarios en internados a los familiares de pacientes, como el cobro de aranceles diferenciados, coaseguros a cargo del afiliado (co-pago) que pudieran corresponder.
- **Facturación a Obras Sociales:** encargada de la confección de los cargos de la Clínica a las Obras Sociales y del control de las liquidaciones que las mismas realicen; (dependiente de Adm.Ctral.).
- **Botiquín:** para la provisión de medicamentos a pacientes internados y la provisión de material descartable médico operativo. (Automatizado por encargo en paralelo).
- **Depósito/Maestranza:** para el aprovisionamiento de material de limpieza, mantenimiento, hotelería y alimentos (imprescindible para el funcionamiento operativo de internados y personal de guardia).

Gestión de INTERNACIONES:

- Tanto para internaciones programadas, como no programadas (urgentes o emergentes), en Mesa de Entradas, debe “Iniciarse la Internación” y registrarse: los datos identificatorios del paciente, del profesional interviniente (y del que -eventualmente- prescribe la internación), del diagnóstico presuntivo principal (y complementarios, de existir), si se adjuntan estudios complementarios previos y los datos necesarios para determinar Obra Social cubrirá la internación. Todos estos datos son impresos y posteriormente entregados a los familiares para su autorización ante la Obra Social. En Mesa de Entradas también se asignará cama: según la disponibilidad, el tipo de diagnóstico y sector al que se lo deriva, sexo, edad y otras cuestiones menores (como ser el pago extra por habitación individual que pida el paciente). También se cobran o rubrican, de corresponder según las Obras Sociales, los depósitos/pagaré de garantía; emitiéndose los respectivos comprobantes en cada caso.
- Una vez internado, el profesional a cargo (“Prestador”), indica (prescribe), en diferentes momentos: las prácticas y/o estudios complementarios a realizar, o los medicamentos a suministrar, los controles especiales (temperatura, pulso, presión, etc.) que se deben ejecutar o la dieta a aplicar en las comidas del internado.
- Cuando se prescribe prácticas o estudios complementarios a un paciente internado, se debe consignar los diferentes diagnósticos presuntivos (registrando su orden de prioridad) y se emiten las “solicitudes de autorización” para las Obras Sociales y adjuntas a las “indicaciones de puño y letra” (en formulario pre-establecido por normas médicas legales); remitiéndose todo a Mesa de Entrada para su posterior entrega a familiares del internado.
- Una vez que los familiares retornan la “Autorización de Prescripción” a Mesa de Entrada, ésta cobra el coseguro (co-pago) a cargo del afiliado (de corresponder), emitiendo el respectivo comprobante y registrando -en el mismo acto- que dicha Prescripción se encuentra autorizada bajo tal número. Posteriormente remite la documentación al Servicio involucrado, para que el Profesional que interviene de conformidad de su intervención.
- Cada vez que se ejecuta una Práctica, se debe dejar constancia de fecha y hora en que se realiza y el/los profesional/es interviniente/s.



- Cuando se indican medicamentos a los pacientes internados se consigna: el Prestador que prescribe, la droga principal (nombre genérico) del medicamento y su graduación o concentración (500 mg/cm³), la presentación (grageas, jarabe, suspensión, inyectable, etc.), cuándo comienza y termina el tratamiento, la periodicidad con la que se tiene que suministrar el mismo y la serie de diagnósticos presuntivos que justifican la citada prescripción. En el mismo acto se emite una “agenda de suministro” con cada uno de los eventos de suministros que deberán llevarse a cabo en Enfermería y un formulario de “solicitud de abastecimiento” con la totalidad de medicamentos que se remite al Botiquín o Droguería de la Clínica para su posterior retiro.
- Cuando se registra el suministro de medicamentos, Enfermería consigna fecha y hora de suministro o aplicación, (en contraposición a la planificada previamente en la agenda) y quién fue el personal que cumplimentó dicha acción. En ciertas ocasiones, cuando se cumplimenta un tratamiento, se actualiza también el estado de la prescripción.
- De manera análoga, cuando decide retirar la aplicación de un medicamento cuya prescripción todavía no fue cumplida en su totalidad (el tratamiento no se completó hasta su fecha de finalización proyectada en la correspondiente agenda), se debe dejar constancia de: quién indica la suspensión (profesional proscriptor), fecha y hora a partir de la cuál suspende el suministro y motivos por los cuales se suspende. En correspondencia, también se deberá no solo actualizar la agenda (deshabilitando las tuplas proyectadas que no se hayan suministrado) y se deberá hacer un remito de “devolución de medicamentos” para devolver a Droguería los medicamentos que no se suministrarán y hayan sido receptados.
- Cuando se indican Controles Especiales a internados se consigna: el profesional que prescribe los Ctrles.Esp., cuándo comienza y termina el tratamiento, la periodicidad con la que se tiene que ejecutar los mismos y la serie de diagnósticos presuntivos que justifican la citada prescripción. En el mismo acto se emite un “cronograma de ejecución” con cada uno de los eventos que deberán llevarse a cabo por Enfermería.
- Cuando se registra la efectivización de Controles Especiales, Enfermería consigna fecha y hora de dicha realización, (en contraposición a la planificada previamente en el cronograma de ejecución), quién fue el personal que cumplimentó dicha acción y el resultado de dicho Control Especial (ej.: temperatura 39°C, presión: 13-9, etc.). En ciertas ocasiones, cuando se cumplimenta un tratamiento, se actualiza también el estado de la prescripción.
- Al finalizar la Internación y previo al alta del paciente, Mesa de Entrada deberá controlar: que toda Prescripción haya retornado con su correspondiente Autorización, que toda Realización efectuada haya sido registrada y se cuente con su respectiva documentación probatoria rubricada; (en caso de faltar alguna, deberá gestionar la misma). Finalmente deberá asentar el reintegro del depósito de garantía/pagaré y pasar a Facturación toda la gestión de la internación. Debe registrar, al alta del paciente, una calificación o motivo y proceder a la liberación de la cama y actualización de disponibilidades.

Administración de FACTURACIÓN a Obras Sociales:

- En el sector de Facturación (perteneciente al área de la Administración Central) se mantienen los datos de las diferentes prácticas / prestaciones médicas y sus respectivos valores, acordados de antemano con cada Obra Social; todo basado en el Nomenclador Nacional INOS (Instituto Nacional de Obras Sociales) de prácticas médicas, cuyos datos y aranceles también son previamente cargados en un trabajo conjunto con Gerencia Médica.
- Evidentemente las Obras Sociales, fechas de facturación y modalidades para realizar la misma (documentación y detalle a adjuntar en cada caso, padrón de afiliados involucrado, copagos pre-cobrados por la Clínica, etc.), son mantenidos por Administración Central.
- Durante el proceso de “Facturación a Obras Sociales”, este sector, organiza y controla la información de todas las prestaciones, “prescriptas”, “autorizadas” y “realizadas”, relacionadas a los pacientes – pertenecientes a una Obra Social en particular- que hayan estado internados durante un período en cuestión. Asimismo, también se agregan todos los medicamentos y controles especiales, suministrados o efectivizados, arancelados que se relacionen con la internación en cuestión.
- Con todo ello, se confecciona una factura, a cada Obra Social, cuyo detalle -por internación (de cada paciente)- se desglosa, a su vez, discriminando cada prestación impartida y consignando el/los Prestador/es intervinientes y se acompaña con fotocopia de documentación pertinente antes descripta. Entonces en la factura, para cada Obra Social de un período determinado, consta el monto global reclamado y, en su detalle, el total requerido por cada internación de un afiliado de esa Obra Social y, dentro de cada internación, se puede descomponer ese monto como la sumatoria de cada una de las prestaciones realizadas (con los profesionales intervinientes); previo descuento de cualquier co-pago previamente cobrado por la Clínica a los pacientes.



- Para poder cumplimentar esto, Administración no solo mantiene los datos de los profesionales y auxiliares para-médicos que trabajan en la Clínica, sino también de los “tipos de profesiones” y una “cuenta de acreditación” de sus honorarios, vinculada a las prestaciones que -cada profesional- realiza dentro de una internación.
- Cuando una Obra Social “liquida” (paga) una Facturación que previamente se le presentara, lo hace consignando cada uno de los ítems o prácticas realizadas que está reconociendo (o debitando) dentro de cada internación incluida en la factura de un período determinado. El sistema, deberá asistir en el control de los ítems (prácticas) cobrados o debitados y a su vez deberá actualizar las cuentas de los prestadores involucrados y “repetirles” la liquidación (pero de manera individual).
- El sector puede consultar ampliamente los datos, tanto totales generales, como detallados, agrupándolos por Obras Sociales, Pacientes, Servicios Prestacionales, Prestadores u otras combinaciones; de las que ahora nos interesa:
- Un prestador puede consultar: qué prácticas tienen por cobrar (facturadas, pero pendiente de liquidación), congregadas por Obra Social y período y a su vez, agrupadas por cada internación involucrada en cada facturación. De igual forma puede consultar las prácticas liquidadas por cada Obra Social y que él tiene disponible su cobro (o saber las razones por las que fueron debitadas dentro de una internación liquidada). Similarmente podrá saber qué prestaciones por él realizadas entrará en la próxima facturación a una Obra Social, haciendo una estimación de sus ingresos en un futuro.